

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b> |            |
| Листовка - Приложение 2                    |            |
| Към Рег. №                                 | 2023 0228  |
| Възв. №                                    | 64155      |
| ВГ/МА/МР                                   | 13-12-2023 |
| BG/MA/MP - 64155                           |            |
| BG/MA/MP - 64155                           |            |

Листовка: информация за потребителя

**Бортезомиб TZF 3,5 mg прах за инжекционен разтвор**  
**Bortezomib TZF 3.5 mg powder for solution for injection**  
 бортезомиб (bortezomib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Бортезомиб TZF и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Бортезомиб TZF
3. Как да използвате Бортезомиб TZF
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бортезомиб TZF
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

## 1. Какво представлява Бортезомиб TZF и за какво се използва

Бортезомиб TZF съдържа активното вещество бортезомиб, така наречения "протеазомен инхибитор". Протеазомите играят важна роля за контрола на клетъчната функция и растеж. Бортезомиб може да унищожи туморните клетки чрез намеса в тяхната функция.

Бортезомиб TZF се използва за лечение на мултиплетен миелом (рак на костния мозък) при пациенти на възраст над 18 години:

- самостоятелно или заедно с лекарствата пегилиран липозомен доксорубицин или дексаметазон, при пациенти, чието заболяване се влошава (прогресира) след получаване на поне едно предходно лечение и при които трансплантацията на кръвни стволови клетки не е била успешна или е неподходяща;
- в комбинация с лекарства, съдържащи мелфалан и преднизон, при пациенти, при които заболяването не е било лекувано преди това и са неподходящи за високодозна химиотерапия с трансплантация на кръвни стволови клетки;
- в комбинация с лекарствата дексаметазон или дексаметазон заедно с талидомид при пациенти, заболяването на които не е било лекувано преди това и преди да получат високодозна химиотерапия с трансплантация на кръвни стволови клетки (индукционно лечение).

Бортезомиб TZF се използва за лечение на мантелноклетъчен лимфом (вид рак, засягащ лимфните възли) при пациенти на 18 години или по-възрастни в комбинация с лекарствата ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин и преднизон, при пациенти, при които заболяването не е било лекувано преди това и за които трансплантацията на кръвни стволови клетки е неподходяща.

## 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Бортезомиб TZF

**Не използвайте Бортезомиб TZF**

- ако сте алергични към бортезомиб, бор или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
- ако имате някакви тежки белодробни или сърдечни проблеми.



### **Предупреждения и предпазни мерки**

Информирайте Вашия лекар, ако имате някое от изброените по-долу състояния:

- нисък брой червени или бели кръвни клетки
- кръвене и/или нисък брой тромбоцити в кръвта
- диария, запек, гадене или повръщане
- слабост, замаяност или световъртеж в миналото
- проблеми с бъбреците
- умерени до тежки чернодробни проблеми
- изтръпване, мравучкане или болка в ръцете или краката (невропатия) в миналото
- проблеми със сърцето или кръвното налягане
- задух или кашлица
- припадъци
- херпес зостер (включително локализиран около очите или обхващащ цялото тяло)
- симптоми на синдром на туморен разпад като например мускулни крампи, мускулна слабост, объркване, загуба или нарушение на зрението и недостиг на въздух
- загуба на паметта, затруднено мислене, трудности при ходене или загуба на зрението. Това могат да бъдат признаци на сериозна мозъчна инфекция и Вашият лекар може да предложи допълнителни изследвания и проследяване.

Преди и по време на лечението с Бортезомиб TZF трябва да си правите периодични изследвания на кръвта, за да проверявате редовно броя на кръвните си клетки.

Ако имате мантилоктъчен лимфом и получавате лекарството ритуксимаб с Бортезомиб TZF трябва да кажете на Вашия лекар:

- ако смятате, че имате инфекция с хепатит в момента или сте имали в миналото. В някои случаи, пациенти, които са имали хепатит В може да получат повторен пристъп на хепатит, който може да бъде фатален. Ако имате анамнеза за инфекция с хепатит В ще бъдете внимателно прегледани от Вашия лекар за признаци на активен хепатит В.

Вие трябва да прочетете листовката за пациента на всеки лекарствен продукт, който ще се приема в комбинация с Бортезомиб TZF, за информация, свързана със съответното лекарство преди започване на лечението с Бортезомиб TZF.

Когато се използва талидомид е необходимо да се обърне особено внимание на тестването за бременност и изискванията за превенция на бременността (вижте Бременност и кърмене в тази точка).

### **Деца и юноши**

Бортезомиб TZF не трябва да се използва при деца и юноши, защото не е известно как ще им повлияе лекарството.

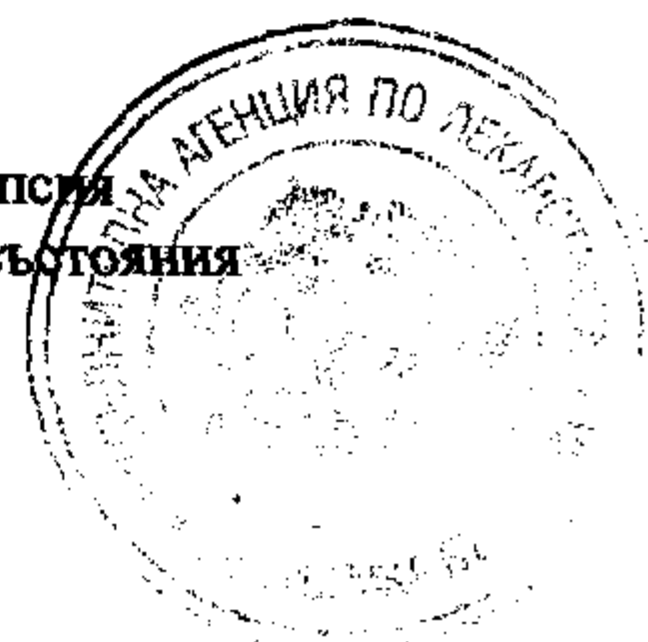
### **Други лекарства и Бортезомиб TZF**

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително такива, отпускани без рецепта.

В частност, информирайте Вашия лекар, ако използвате лекарства, съдържащи някое от следните активни вещества:

- кетоконазол, използван за лечение на гъбични инфекции
- ритонавир, използван за лечение на HIV инфекция
- рифампицин, антибиотик, използван за лечение на бактериални инфекции
- карбамазепин, фенитоин или фенobarбитал, използвани за лечение на епилепсия
- жълт кантарион (*Hypericum perforatum*), използван при депресии или други състояния
- перорални антидиабетни лекарства

### **Бременност и кърмене**





Не трябва да използвате Бортезомиб TZF ако сте бременна, освен в случай на категорична необходимост.

И мъжете, и жените, на които се прилага Бортезомиб TZF, трябва да използват ефективни методи за контрацепция по време на и до 3 месеца след лечението. Ако, независимо от тези мерки, настъпи бременност, веднага информирайте Вашия лекар.

Не трябва да кърмите, докато използвате Бортезомиб TZF. Обсъдете с Вашия лекар кога е безопасно да подновите кърменето, след приключване на лечението.

Талидомид причинява вродени малформации и смърт на плода. Когато Бортезомиб TZF се прилага в комбинация с талидомид, трябва да следвате програмата за превенция на бременността при лечение с талидомид (вижте Листовка за пациента на талидомид).

### **Шофиране и работа с машини**

Бортезомиб TZF може да причини умора, замаяност, слабост или замъглено зрение. Не шофирайте и не работете с инструменти или машини, ако имате подобни нежелани реакции; дори ако ги нямате, трябва да сте внимателни.

## **3. Как да използвате Бортезомиб TZF**

Вашият лекар ще определи Вашата доза Бортезомиб TZF в зависимост от височината и теглото Ви (площ на телесната повърхност). Обичайната начална доза на Бортезомиб TZF е  $1,3 \text{ mg/m}^2$  телесна повърхност два пъти седмично.

Вашият лекар може да промени дозата и общия брой лечебни цикли в зависимост от повлияването Ви от лечението, от възникването на някои нежелани реакции и от Вашите съпътстващи заболявания (например, проблеми с черния дроб).

### *Прогресиращ мултиплен миелом*

Когато Бортезомиб TZF се прилага самостоятелно, Вие ще получите 4 дози Бортезомиб TZF интравенозно или подкожно на ден 1, 4, 8 и 11, последвани от 10-дневен “период на почивка” без лечение. Този 21-дневен период (3 седмици) съответства на един цикъл на лечение. Вие може да получите до 8 цикъла (24 седмици).

Бортезомиб TZF може да Ви бъде прилаган заедно с лекарствата пегилиран липозомен доксорубицин или дексаметазон.

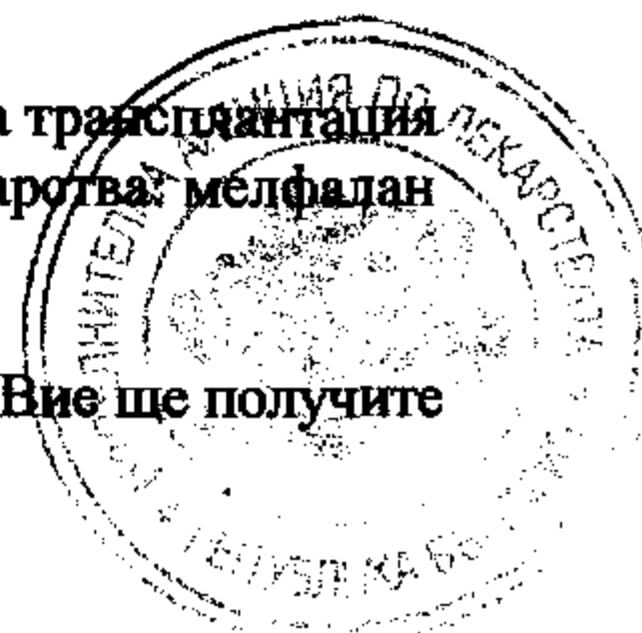
Когато Бортезомиб TZF се прилага заедно с пегилиран липозомен доксорубицин, Вие ще получите Бортезомиб TZF интравенозно или подкожно като 21-дневен цикъл на лечение и пегилиран липозомен доксорубицин приложен в доза  $30 \text{ mg/m}^2$  на ден 4 от 21-дневния цикъл на лечение с Бортезомиб TZF като интравенозна инфузия след инжектирането на Бортезомиб TZF. Вие може да получите до 8 цикъла (24 седмици).

Когато Бортезомиб TZF се прилага заедно с дексаметазон, Вие ще получите Бортезомиб TZF интравенозно или подкожно като 21-дневен цикъл на лечение и дексаметазон  $20 \text{ mg}$ , приложен перорално в дни 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 и 12 от 21-дневния цикъл на лечение с Бортезомиб TZF. Вие може да получите до 8 цикъла (24 седмици).

### *Нелекуван мултиплен миелом*

Ако преди не сте били лекувани за мултиплен миелом и Вие не сте подходящи за трансплантация на кръвни стволови клетки, ще получите Бортезомиб TZF заедно с две други лекарства: мелфалан и преднизон.

В този случай продължителността на терапевтичния цикъл е 42 дни (6 седмици). Вие ще получите 9 цикъла (54 седмици).



- В циклите от 1 до 4, Бортезомиб TZF се прилага два пъти седмично на ден 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 и 32.
- В циклите от 5 до 9, Бортезомиб TZF се прилага веднъж седмично на ден 1, 8, 22 и 29. Мелфалан ( $9 \text{ mg/m}^2$ ) и преднизон ( $60 \text{ mg/m}^2$ ) се прилагат перорално в ден 1, 2, 3 и 4 от първата седмица на всеки цикъл.

Ако преди не сте били лекувани за мултиплен миелом и Вие сте подходящи за трансплантация на кръвни стволови клетки Вие ще получите Бортезомиб TZF интравенозно или подкожно заедно с лекарствата дексаметазон самостоятелно или дексаметазон и талидомид, като индукционно лечение.

Когато Бортезомиб TZF се прилага заедно с дексаметазон, Вие ще получите Бортезомиб TZF интравенозно или подкожно като 21-дневен цикъл на лечение и дексаметазон  $40 \text{ mg}$  приложен перорално в дни 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 от 21-дневния цикъл на лечение с Бортезомиб TZF. Вие ще получите 4 цикъла (12 седмици).

Когато Бортезомиб TZF се прилага заедно с талидомид и дексаметазон, продължителността на терапевтичния цикъл е 28 дни (4 седмици).

Дексаметазон  $40 \text{ mg}$  се прилага перорално в дни 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 от 28-дневния цикъл на лечение с Бортезомиб TZF и талидомид приложен перорално ежедневно в доза от  $50 \text{ mg}$  до ден 14 от първия цикъл и ако се понася добре дозата на талидомид се повишава до  $100 \text{ mg}$  в периода от ден 15 до ден 28, след което може да бъде повишена допълнително до  $200 \text{ mg}$  от втория цикъл нататък.

Вие може да получите до 6 цикъла на лечение (24 седмици).

#### *Нелекуван мантелноклетъчен лимфом*

Ако не сте лекувани досега за клетъчен лимфом на мангията ще получите Бортезомиб TZF интравенозно или подкожно заедно с лекарствата ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин и преднизон. Бортезомиб TZF се прилага интравенозно или подкожно на ден 1, 4, 8 и 11, последвано от "период на почивка" без лечение. Продължителността на цикъла на лечение е 21 дни (3 седмици). Могат да се приложат до 8 цикъла (24 седмици).

Следните лекарствени продукти се прилагат на ден 1 на всеки 21-дневен цикъл на лечение с Бортезомиб TZF като интравенозни инфузии: Ритуксимаб в доза  $375 \text{ mg/m}^2$ , циклофосфамид в доза  $750 \text{ mg/m}^2$  и доксорубицин в доза  $50 \text{ mg/m}^2$ . Преднизон се прилага перорално в доза  $100 \text{ mg/m}^2$  на ден 1, 2, 3, 4 и 5 от цикъла на лечение с Бортезомиб TZF.

#### **Как се прилага Бортезомиб TZF**

Това лекарство е само за интравенозна или подкожна употреба. Бортезомиб TZF ще се прилага от медицински специалист с опит при употребата на цитотоксични лекарства.

Бортезомиб TZF на прах трябва да се разтвори преди употреба. Това ще се направи от медицински специалист. След това полученият разтвор се инжектира във вена или под кожата. Инжектирането във вена е бързо, прави се за 3 до 5 секунди. Инжектирането под кожата се прави в областта на бедрата или корема.

#### **Ако Ви е приложен твърде много Бортезомиб TZF**

Тъй като това лекарство се прилага от Вашия лекар или медицинска сестра, малко вероятно е да Ви бъде приложено твърде много. В малко вероятния случай на предозиране, Вашият лекар ще Ви наблюдава за нежелани реакции.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Някои от тези реакции могат да бъдат сериозни.





Ако Ви прилагат Бортезомиб TZF за мултиплен миелом или мантелноклетъчен лимфом, информирайте Вашия лекар, ако имате някой от изброените по-долу симптоми:

- мускулни крампи, мускулна слабост
- объркване, загуба или нарушение на зрението, слепота, гърчове, главоболие
- задух, подуване на краката, или промени в сърдечния ритъм, високо кръвно налягане, умора, прималвяване
- кашлица и затруднено дишане или стягане в гърдите.

Лечението с Бортезомиб TZF може много често да предизвика намаление на броя на червените и бели кръвни клетки и тромбоцитите в кръвта Ви. Ето защо трябва да си правите периодични изследвания на кръвта преди и по време на лечението с Бортезомиб TZF, за да проверявате редовно броя на кръвните си клетки. Може да имате намаляване в броя на:

- тромбоцитите, което може да Ви направи по-склонни към образуване на синини или кръвене без видимо нараняване (напр. кръвене от червата, стомаха, устата и венците или кръвене в мозъка, или кръвене от черния дроб)
- червените кръвни клетки, което може да предизвика анемия със симптоми като умора и бледост
- белите кръвни клетки, което може да Ви направи по-склонни към инфекции и грипоподобни симптоми.

Ако Ви е приложен Бортезомиб TZF за лечение на мултиплен миелом нежеланите реакции, които може да получите, са изброени по-долу:

**Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)**

- Чувствителност, скованост, изтръпване или усещане за парене на кожата, или болки връцете или краката, поради увреждане на нервите
- Намаляване броя на червените кръвни клетки и/или белите кръвни клетки (вижте по-горе)
- Треска
- Гадене или повръщане, загуба на апетит
- Запек с или без подуване на корема (може да е тежък)
- Диария: ако това се случи, важно е да пиете повече вода отколкото обикновено. Лекарят може да Ви даде друго лекарство за контрол на диарията
- Умора (изтощение), усещане за слабост
- Мускулна болка, болка в костите

**Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)**

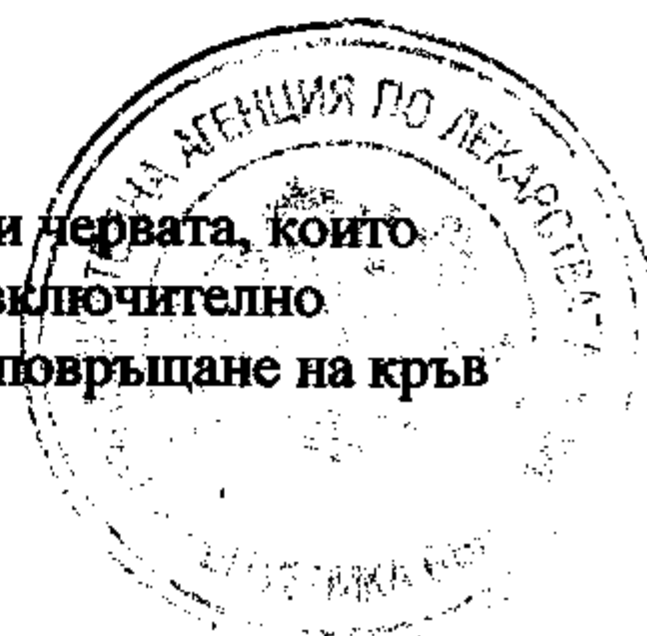
- Ниско кръвно налягане, рязко спадане на артериалното налягане при ставане, което може да доведе до прилошаване
- Високо кръвно налягане
- Намалена бъбречна функция
- Главоболие
- Общо неразположение, болка, световъртеж, леко замаяване, чувство за слабост или загуба на съзнание
- Треперене
- Инфекции, включително пневмония, респираторни инфекции, бронхит, гъбични инфекции, кашлица с храчки, грипоподобни заболявания
- Херпес зостер (включително разположен около очите или разпространен по тялото)
- Болка в гърдите или недостиг на въздух при физическо усилие
- Различни видове обрив
- Сърбеж по кожата, грапава или суха кожа
- Зачервяване на лицето или малки спукани капиляри
- Зачервяване на кожата
- Дехидратация (обезводняване)
- Киселини, подуване на корема, оригване, газове, болки в стомаха, кръвене от червата или стомаха



- Промяна във функцията на черния дроб
- Възпаление на устата или устните, сухота в устата или болка в гърлото
- Загуба на тегло, загуба на вкуса
- Мускулни крампи, мускулни спазми, мускулна слабост, болка във Вашите крайници
- Замъглено зрение
- Инфекция на външния слой на окото и вътрешната повърхност на клепачите (конюнктивит)
- Кървене от носа
- Трудно заспиване или проблеми със съня, изпотяване, тревожност, промени в настроението, потиснато настроение, безпокойство или възбуда, промени в психическото състояние, дезориентация
- Подуване на тялото, включително около очите или други части от тялото

**Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)**

- Сърдечна недостатъчност, инфаркт, гръдна болка, дискомфорт в гърдите, повишена или понижена сърдечна честота
- Бъбречна недостатъчност
- Възпаление на вените, кръвни съсиреци във вените или белите дробове
- Проблеми със съсирването на кръвта
- Недостатъчна циркулация
- Възпаление на обвивката около сърцето или течността около сърцето
- Инфекции, включващи инфекция на пикочните пътища, грип, херпес вирусна инфекция, ушна инфекция и целулит
- Кървави изпражнения или кървене от лигавиците, например в устата, влагалището
- Мозъчносъдови нарушения
- Парализа, припадъци, падане, двигателни нарушения, нарушена, променена или намалена чувствителност (усещане, слух, вкус, обоняние), нарушено внимание, треперене, потрепвания
- Артрит, включително възпаление на ставите на пръстите на ръцете и краката, и на челюстта
- Нарушения, които засягат Вашите бели дробове, които възпрепятстват получаването на достатъчно кислород от тялото. Някои от нарушенията включват затруднено дишане, задух, задух в покой, повърхностно затруднено или прекъсващо дишане, хрипове
- Хълцане, говорни нарушения
- Повишено или намалено количество урина (поради бъбречно увреждане), болезнено уриниране или наличие на кръв/белтък в урината, задържане на течности
- Променено ниво на съзнание, объркване, увреждане или загуба на паметта
- Свръхчувствителност
- Загуба на слуха, глухота или шум в ушите, дискомфорт в ушите
- Хормонални нарушения, които могат да засегнат усвояването на сол и вода
- Свръхактивност на щитовидната жлеза
- Неспособност за произвеждане на достатъчно инсулин или резистентност към нормалните нива на инсулин
- Раздразнени или възпалени очи, силно сълзящи очи, болка в очите, сухи очи, очни инфекции, бучка в клепача (халацион), зачервени и подути клепачи, секрет от очите, нарушено зрение, кървене от очите
- Подуване на лимфните възли
- Скованост на стави или мускули, усещане за тежест, болки в слабините
- Косопад и нарушена структура на косъма
- Алергични реакции
- Зачервяване или болка на мястото на инжектиране
- Болки в устата
- Инфекции или възпаление на устата, язви в устата, хранопровода, стомаха и червата, които понякога са свързани с болка или кървене, забавено движение на червата (включително запущване), дискомфорт в корема или хранопровода, трудно преглъщане, повръщане на кръв
- Кожни инфекции
- Бактериални и вирусни инфекции

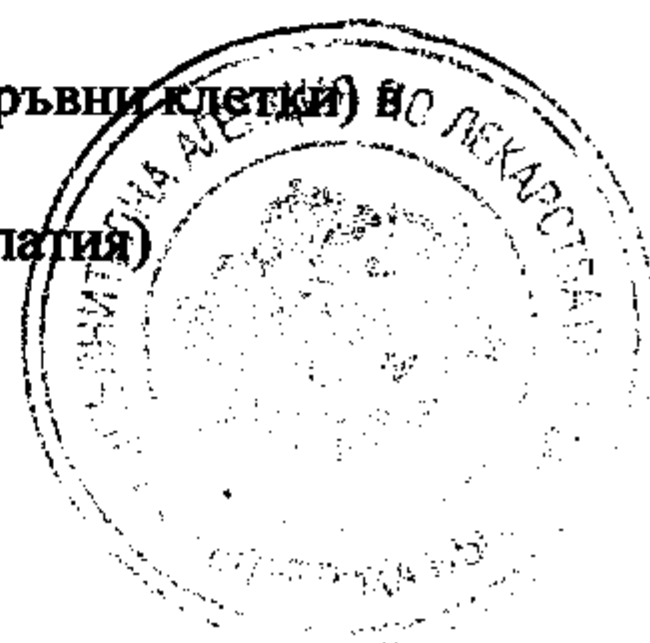




- Инфекция на зъбите
- Възпаление на панкреаса, запушване на жлъчните пътища
- Болка в гениталиите, проблеми с получаването на ерекция
- Повишаване на телото
- Жажда
- Хепатит
- Нарушения на мястото на приложение или свързани с изделието за приложение
- Кожни реакции и нарушения (които може да са тежки и животозастрашаващи), кожни язви
- Синини, падания и наранявания
- Възпаление или кръвоизливи от кръвоносните съдове, което може да се прояви като малки червени или лилави точки (обикновено по краката), до големи петна под кожата или меките тъкани
- Доброкачествени кисти
- Тежко обратимо състояние на мозъка, което включва припадъци, високо кръвно налягане, главоболие, умора, обърканост, слепота или други проблеми със зрението.

**Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)**

- Сърдечни проблеми, включващи инфаркт, стенокардия
- Зачервяване
- Промяна в цвета на вените
- Възпаление на гръбначен нерв
- Проблеми с Вашите уши, кръвене от ушите
- Намалена активност на щитовидната жлеза
- Синдром на Бъд-Киари (клинични симптоми, причинени от запушване на чернодробните вени)
- Променена или нарушена чревна функция
- Кървене в мозъка
- Жълто оцветяване на очите и кожата (жълтеница)
- Сериозна алергична реакция (анафилактичен шок), която може да включва признаци на затруднено дишане, болка или стягане в гръдния кош, и/или чувство на замаяност/слабост, силен сърбеж по кожата или надигнат обрив по кожата, подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, които могат да причинят затруднение при преглъщане, колапс
- Нарушения на гърдите
- Вагинално течение
- Подуване на гениталиите
- Непоносимост към консумация на алкохол
- Загуба на телесна маса
- Повишен апетит
- Фистула
- Ставен излив
- Кисти в обвивките на ставите (синовиални кисти)
- Счупвания
- Разпадане на мускулни влакна, водещо до други усложнения
- Оток на черния дроб, кръвене от черния дроб
- Рак на бъбреците
- Състояние на кожата, подобно на псориазис
- Рак на кожата
- Бледост на кожата
- Повишаване броя на тромбоцитите или плазматичните клетки (вид бели кръвни клетки) в кръвта
- Кръвни съсиреци в малките кръвоносни съдове (тромботична микроангиопатия)
- Абнормна реакция при кръвопреливане
- Частична или пълна загуба на зрението
- Намалено сексуално желание



- Лигавене
- Изпъкване на очите
- Чувствителност към светлина
- Учестено дишане
- Болка в правото черво
- Камъни в жлъчката
- Херния
- Наранявания
- Чупливи или тънки нокти
- Необичайни белтъчни отлагания в жизненоважните органи
- Кома
- Чревни язви
- Мултиорганна недостатъчност
- Смърт
- Сериозно възпаление на нервите, което може да причини парализа и затруднено дишане (синдром на Гилен-Баре)

Ако Ви е приложен Бортезомиб TZF заедно с други лекарства за лечение на мантелноклетъчен лимфом нежеланите реакции, които могат да се получат, са изброени по-долу:

**Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)**

- Пневмония
- Загуба на апетит
- Чувствителност, скованост, изтръпване или усещане за парене на кожата, или болки в китките или стъпалата, поради увреждане на нервите
- Гадене и повръщане
- Диария
- Язви в устата
- Запек
- Болка в мускулите, болка в костите
- Косопад и нарушена структура на косъма
- Умора, усещане за слабост
- Треска

**Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)**

- Херпес зостер (включително разположен около очите или разпространен по тялото)
- Херпес вирусни инфекции
- Бактериални и вирусни инфекции
- Инфекции на дихателните пътища, бронхит, кашлица с храчки, грипоподобни заболявания
- Гъбични инфекции
- Свръхчувствителност (алергична реакция)
- Неспособност за произвеждане на достатъчно инсулин или резистентност към нормалните нива на инсулин
- Задържане на течности
- Трудно заспиване или проблеми със съня
- Загуба на съзнание
- Променено ниво на съзнание, объркване
- Чувство на замаяване
- Учестена сърдечна дейност, високо кръвно налягане, изпотяване
- Нарушения в зрението, замъглено зрение
- Сърдечна недостатъчност, инфаркт, гръдна болка, дискомфорт в гърдите, повишена или понижена сърдечна честота
- Високо или ниско кръвно налягане





- Внезапно спадане на кръвното налягане при изправяне, което може да доведе до загуба на съзнание
- Недостиг на въздух при физическо усилие
- Кашлица
- Хълцане
- Шум в ушите, дискомфорт в ушите
- Кървене от червата или стомаха
- Киселини в стомаха
- Болки в стомаха, подуване на корема
- Затруднено преглъщане
- Инфекция или възпаление на стомаха и червата
- Болки в стомаха
- Възпаление на устата или устните, болки в гърлото
- Промяна във функцията на черния дроб
- Сърбеж на кожата
- Зачервяване на кожата
- Обрив
- Мускулни спазми
- Инфекция на пикочните пътища
- Болка в крайниците
- Подуване на части на тялото, включително около очите или други части на тялото
- Треперене
- Зачервяване и болка на мястото на инжектиране
- Общо неразположение
- Загуба на тегло
- Повишаване на теглото

**Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)**

- Хепатит
- Сериозна алергична реакция (анафилактичен шок), която може да включва признаци на затруднено дишане, болка или стягане в гръдния кош, и/или чувство на замаяност/слабост, силен сърбеж по кожата или надигнат обрив по кожата, подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, които могат да причинят затруднение при преглъщане, колапс
- Двигателни разстройства, парализа, потрепване на мускулите
- Световъртеж
- Загуба на слуха, глухота
- Нарушения, които засягат Вашите бели дробове, които възпрепятстват получаването на достатъчно кислород от тялото. Някои от нарушенията включват затруднено дишане, задух, задух в покой, повърхностно затруднено или прекъсващо дишане, хрипове
- Кръвни съсиреци в белите дробове
- Жълто оцветяване на кожата и очите (жълтеница)
- Бучка в клепача (халацион), зачервени и подути клепачи

**Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)**

- Кръвни съсиреци в малките кръвоносни съдове (тромботична микроангиопатия)

**Съобщаване на нежелани реакции**

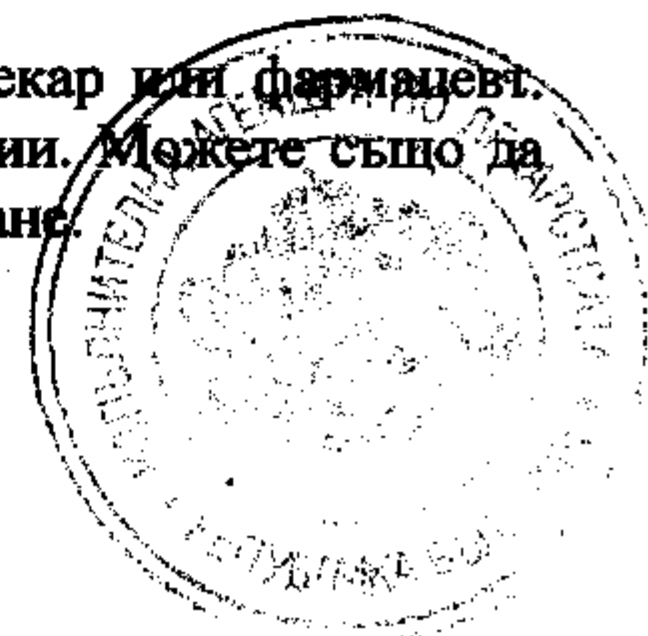
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване.

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## **5. Как да съхранявате Бортезомиб TZF**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху флакона и картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. „Партида:“ означава партидният номер.

Това лекарство не изисква специални температурни условия на съхранение. Съхранявайте флакона в картонената кутия, за да се предпази от светлина.

### **Приготвен разтвор**

Химичната и физичната стабилност при употреба е доказана за 8 часа при 25°C в оригиналния флакон и/или спринцовка. От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва незабавно, освен ако методът на отваряне/разтваряне/разреждане изключва риска от микробно замърсяване.

Ако не се използва веднага, времето и условията за съхранение преди употреба са отговорност на потребителя.

Да не се съхранява в хладилник.

Не използвайте това лекарство, ако забележите частици и промяна на цвета преди приложение.

Бортезомиб TZF е само за еднократна употреба. Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с местните изисквания.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа Бортезомиб TZF**

- Активно вещество е бортезомиб. Всеки флакон съдържа 3,5 mg бортезомиб (като манитол боронов естер).
- Другата съставка е манитол (E421).

### **Интравенозно приложение:**

След приготвяне, 1 ml от разтвора за интравенозна инжекция съдържа 1 mg бортезомиб.

### **Подкожно приложение:**

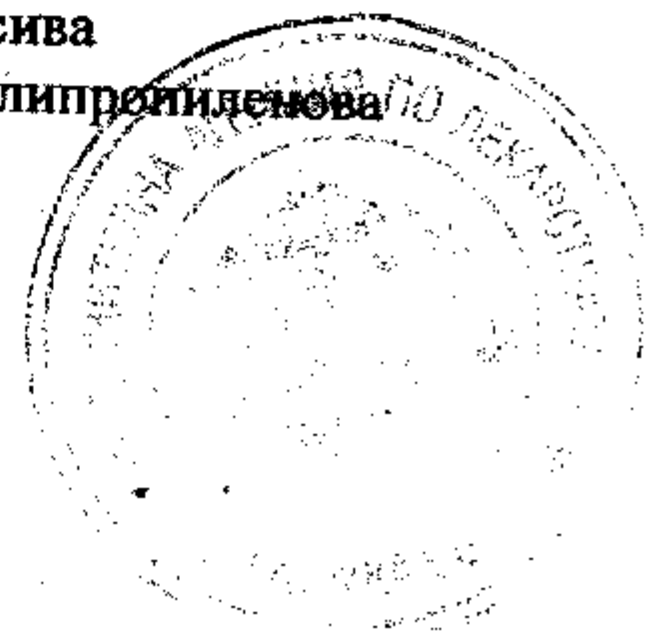
След приготвяне, 1 ml от разтвора за подкожна инжекция съдържа 2,5 mg бортезомиб.

**Как изглежда Бортезомиб TZF и какво съдържа опаковката**  
Бортезомиб TZF е бяла до почти бяла компактна маса или прах.

Бортезомиб TZF се прилага във флакон от безцветно стъкло (тип 1) от 8 ml със сива бромобутилова гумена запушалка и алуминиева обкатка с бяла отчупваща се полипропиленова капачка, съдържаща 3,5 mg бортезомиб.

Всяка опаковка съдържа 1 флакон за еднократна употреба.

**Притежател на разрешението за употреба**





Tarchomin Pharmaceutical Works "Polfa" S.A.  
2, A. Fleminga Street  
03-176 Warsaw  
Полша

**Производител**

SIA RHARMIDEA  
4 Rupnicu Street  
Olaine LV- 2114  
Латвия

Това лекарство е разрешено за употреба в държавите-членки на Европейското икономическо пространство под следните имена:

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Полша    | Bortezomib TZF                                                 |
| България | Бортезомиб TZF 3,5 mg прах за инжекционен разтвор              |
| Литва    | Bortezomib TZF 3,5 mg milteliai injekciniam tirpalui           |
| Латвия   | BORTEZOMIB TZF 3,5 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai |

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

**1. ПРИГОТВЯНЕ ЗА ИНТРАВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ**

Забележка: Бортезомиб TZF е цитотоксичен лекарствен продукт. Затова по време на работа и приготвяне трябва да се проявява повишено внимание. Препоръчва се употребата на ръкавици и друго защитно облекло за предпазване от контакт с кожата.

**ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА С БОРТЕЗОМИБ TZF ТРЯБВА СТРИКТНО ДА СЕ СПАЗВА АСЕПТИЧНА ТЕХНИКА, ТЪЙ КАТО НЕ СЪДЪРЖА КОНСЕРВАНТ.**

**1.1 Приготвяне на флакон от 3,5 mg:**

Внимателно добавете 3,5 ml стерилен 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор на натриев хлорид към флакона, съдържащ Бортезомиб TZF прах, като използвате спринцовка с подходящ размер, без да отстранявате запушалката на флакона. Разтварянето на лиофилизирания прах се извършва за по-малко от 2 минути.

Концентрацията на получения разтвор ще бъде 1 mg/ml. Разтворът ще бъде бистър и безцветен, без видими частици, с крайно pH от 4 до 7. Не е необходимо да проверявате pH на разтвора.

1.2 Преди прилагане, визуално проверете разтвора за наличие на видими частици и промяна в цвета. Ако се наблюдава някаква промяна в цвета или видими частици, разтворът трябва да се изхвърли. Убедете се, че е приготвена точната доза за интравенозно приложение (1 mg/ml).

**1.3 Приготвен разтвор**

Химичната и физичната стабилност при употреба е доказана за 8 часа при 25°C в оригиналния флакон и/или спринцовка. От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва незабавно, освен ако методът на отваряне/разтваряне/разреждане изключва риска от микробно замърсяване. Ако не се използва веднага, времето и условията за съхранение преди употреба са отговорност на потребителя.

Да не се съхранява в хладилник.

Не е необходимо разтвореният продукт да се пази от светлина.

## 2. ПРИЛОЖЕНИЕ

- След разтваряне, изтеглете съответното количество от приготвения разтвор според изчислената доза за телесната повърхност на пациента.
- Потвърдете дозата и концентрацията в спринцовката преди употреба (проверете дали спринцовката е маркирана за интравенозно приложение).
- Инжектирайте разтвора като болус интравенозна инжекция през периферен или централен интравенозен катетър във вена за 3 - 5 секунди.
- Промийте периферния или централен интравенозен катетър със стерилен 9 mg/ml (0,9%) разтвор на натриев хлорид.

**БОРТЕЗОМИБ TZF Е САМО ЗА ПОДКОЖНО ИЛИ ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ.**  
Да не се прилага по други пътища. Инtrateкалното приложение води до смърт.

## 3. ИЗХВЪРЛЯНЕ

Флаконът е само за еднократна употреба и останалият разтвор трябва да се изхвърли. Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с местните изисквания.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:  
Само флаконът от 3,5 mg може да се прилага подкожно, както е описано по-долу.

### 1. ПРИГОТВЯНЕ ЗА ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ

Забележка: Бортезомиб TZF е цитотоксичен лекарствен продукт. Затова по време на работа и приготвяне трябва да се проявява повишено внимание. Препоръчва се употребата на ръкавици и друго защитно облекло за предпазване от контакт с кожата.

**ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА С БОРТЕЗОМИБ TZF ТРЯБВА СТРИКТНО ДА СЕ СПАЗВА АСЕПТИЧНА ТЕХНИКА, ТЪЙ КАТО НЕ СЪДЪРЖА КОНСЕРВАНТ.**

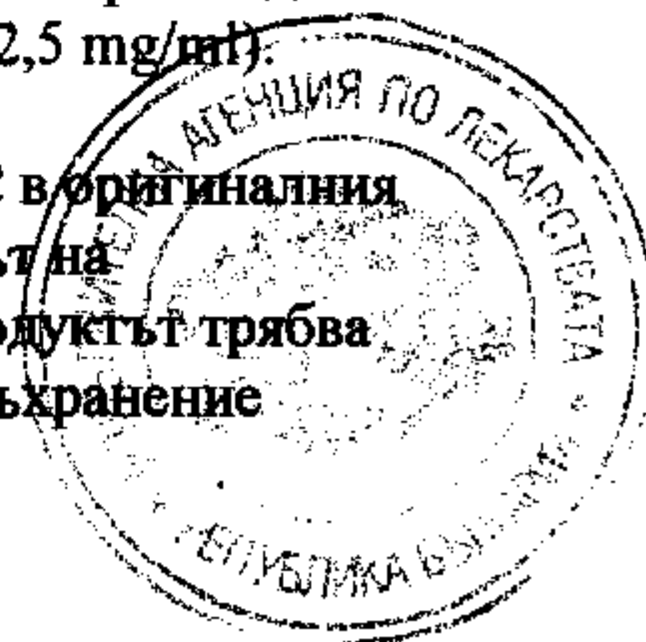
#### 1.1 Приготвяне на флакон от 3,5 mg:

Внимателно добавете 1,4 ml стерилен 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор на натриев хлорид към флакона, съдържащ Бортезомиб TZF прах, като използвате спринцовка с подходящ размер, без да отстранявате запушалката на флакона. Разтварянето на лиофилизирания прах се извършва за по-малко от 2 минути.

Концентрацията на получения разтвор ще бъде 2,5 mg/ml. Разтворът ще бъде бистър и безцветен с крайно pH от 4 до 7. Не е необходимо да проверявате pH на разтвора.

#### 1.2 Преди прилагане, визуално проверете разтвора за наличие на видими частици и промяна в цвета. Ако се наблюдава някаква промяна в цвета или видими частици, разтворът трябва да се изхвърли. Убедете се, че е приготвена точната доза за подкожно приложение (2,5 mg/ml).

#### 1.3 Химичната и физичната стабилност при употреба е доказана за 8 часа при 25°C в оригиналния флакон и/или спринцовка. От микробиологична гледна точка, освен ако методът на отваряне/разтваряне/разреждане изключва риска от микробно замърсяване, продуктът трябва да се използва незабавно. Ако не се използва веднага, времето и условията за съхранение преди употреба са отговорност на потребителя. Да не се съхранява в хладилник.





Не е необходимо разтвореният продукт да се пази от светлина.

## **2 ПРИЛОЖЕНИЕ**

- След разтваряне, изтеглете съответното количество от приготвения разтвор според изчислената доза за телесната повърхност на пациента.
- Потвърдете дозата и концентрацията в спринцовката преди употреба (проверете дали спринцовката е маркирана за подкожно приложение).
- Инжектирайте разтвора подкожно, под ъгъл от 45-90°.
- Приготвеният разтвор се прилага подкожно в областта на бедрата (в лявото или в дясното) или в областта на корема (в ляво или в дясно).
- Местата за инжектиране трябва да се редуват за успешно инжектиране.
- Ако се наблюдава локална реакция на мястото на приложение след подкожно инжектиране на Бортезомиб TZF, се препоръчва да се прилага по-ниска концентрация на Бортезомиб TZF (1 mg/ml вместо 2,5 mg/ml) или преминаване към интравенозно приложение.

**БОРТЕЗОМИБ TZF Е САМО ЗА ПОДКОЖНО ИЛИ ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ.**  
Да не се прилага по други пътища. Интратекалното приложение води до смърт.

## **3 ИЗХВЪРЛЯНЕ**

Флаконът е само за еднократна употреба и останалият разтвор трябва да се изхвърли. Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с местните изисквания.

